

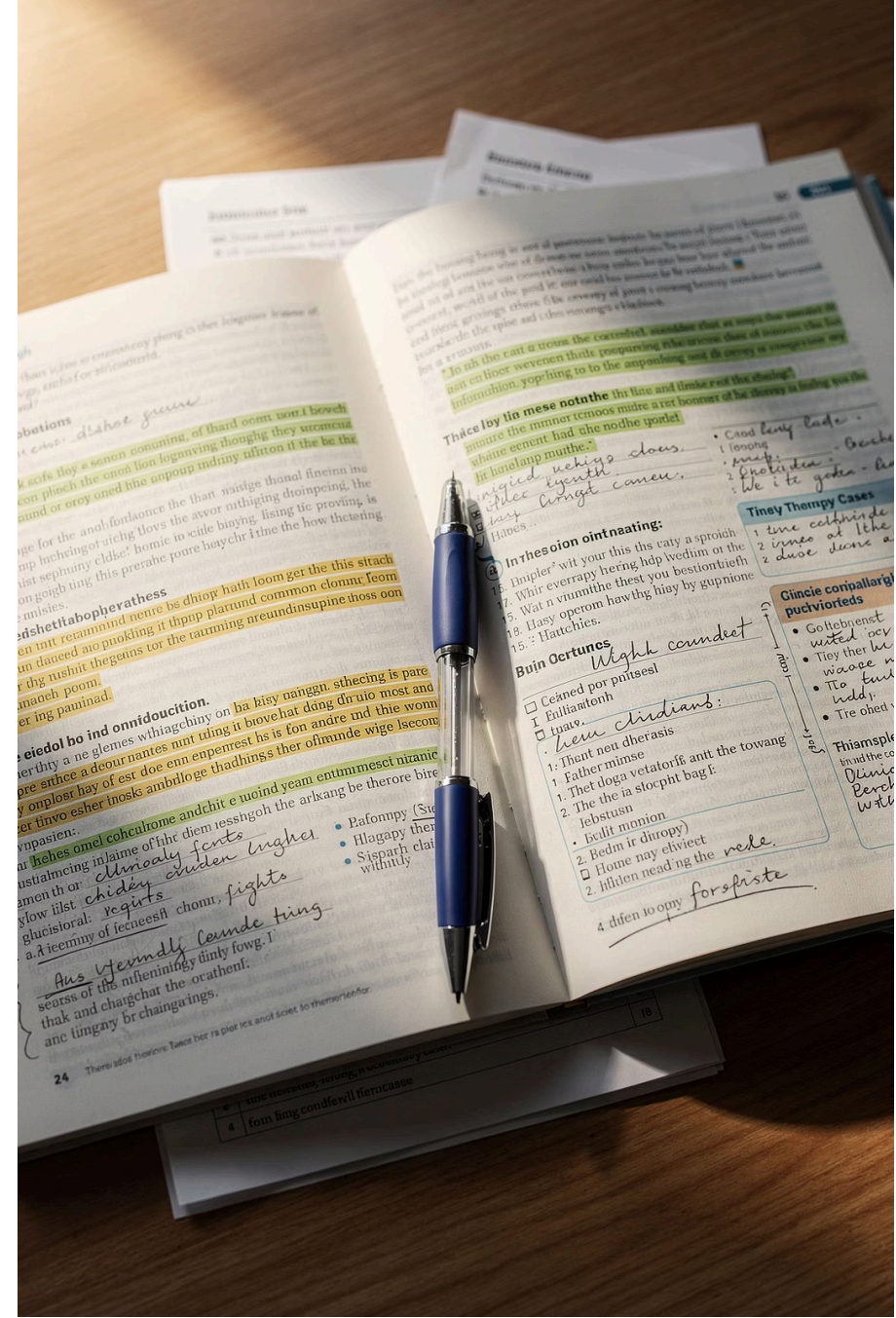
اضطرابات الشخصية العشرة وفق DSM-5

Personality Disorders according to DSM-5

دليل علمي وتشخيصي وعلاجي للأخصائيين النفسيين

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION

DSM-5-TR



مقدمة: الشخصية واضطراباتهما

متى تصبح الشخصية "اضطرابًا"؟

تتحول سمات الشخصية إلى اضطراب حين تصبح صلبة وغير مرنة، وتسبب ضيقًا نفسيًا أو إعاقة وظيفية ملحوظة. الفارق الجوهرى: السمات الشخصية طبيعية ومرنة، أما في الاضطراب فهي متصلبة ومتفشية وتستمر عبر الزمن وعبر مواقف متعددة.

- ❑ اضطرابات الشخصية من أكثر الاضطرابات تعقيدًا كونها أنماط راسخة تبدأ مبكرًا، وغالبًا ما يفتقر المريض إلى البصيرة بمشكلته.

ما هي الشخصية؟

الشخصية هي مجموعة الأنماط الثابتة نسبيًا في التفكير والمشاعر والسلوك التي تميز الفرد وتحدد طريقة تفاعله مع العالم والآخرين. تتشكل هذه الأنماط عبر التفاعل بين العوامل الجينية والبيئية والتجارب المبكرة.



معايير اضطرابات الشخصية في DSM-5

يشترط DSM-5 لتشخيص اضطراب الشخصية توافر مجموعة من المحكات الجوهرية التي تضمن الدقة التشخيصية وتستبعد الأسباب العضوية والوظيفية.

1	النمط الداخلي المنحرف نمط ثابت يظهر في مجالين أو أكثر: الإدراك (للذات والآخرين والأحداث)، العاطفة، الأداء الاجتماعي، والسيطرة على الاندفاعية.
2	الانتشار والصلابة يكون النمط متصلبًا ومتفشيًا عبر مجموعة واسعة من السياقات الاجتماعية والمهنية والشخصية، وليس مقتصرًا على مواقف بعينها.
3	الضيق والإعاقة الوظيفية يسبب النمط ضيقًا ذاتيًا ملحوظًا أو إعاقة وظيفية في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها من مجالات الحياة.
4	الاستمرارية والبدء المبكرة يُعد النمط ثابتًا وطويل الأمد، ويمكن تتبع بداياته إلى مرحلة المراهقة أو أوائل مرحلة البلوغ على أقل تقدير.
5	استبعاد الأسباب الأخرى لا يُعزى النمط إلى تأثيرات فسيولوجية لمادة أو حالة طبية عامة، ولا يُفسر على أنه مظهر أو نتيجة لاضطراب نفسي آخر.

تصنيف اضطرابات الشخصية: المجموعات الثلاث

يُصنّف DSM-5 اضطرابات الشخصية العشرة ضمن ثلاث مجموعات (Clusters) بناءً على التشابه في السمات والمظاهر السريرية.

المجموعة	الاضطرابات	السمات الرئيسية	الوصف الإجمالي
الغريب — A	الزورانية، الفصامية، شبه الفصامية	التفكير الغريب، الانسحاب الاجتماعي، الوهمية، الجمود العاطفي	Odd / Eccentric
الدرامي — B	المعادية للمجتمع، الحدية، الهستيرية، الرجسية	الاندفاع، الدراما الانفعالية، تقلب المزاج، التلاعب والعظمة	Dramatic / Emotional / Erratic
القلق — C	التجنّبية، الاعتمادية، الوسواسية القهرية	القلق المزمن، الخوف من الرفض، التمسك، الكمالية والجمود	Anxious / Fearful



يُسمح سريريًا بتشخيص اضطراب شخصية مزدوج لدى المريض الواحد إن استوفت كلتا الصورتين معايير التشخيص.

اضطراب الشخصية الزورانية — Paranoid Personality Disorder

التشخيص الفارق والعلاج

الفارق عن الفصام: لا توجد هلاوس أو أوهام راسخة. الفارق عن الاضطراب الوهامي: الأفكار الزورانية غير بلغت مستوى الوهام المنظم.

الأسباب المحتملة

- تاريخ من الإساءة أو الإهمال في الطفولة
- عوامل وراثية مرتبطة بطيف الفصام
- آليات دفاع نفسية: الإسقاط والإنكار

العلاج

- تحدي التفسيرات الزورانية وبناء الثقة التدريجي: CBT
- العلاج الداعم: تعزيز التحالف العلاجي باحتراس
- دوائياً: مضادات الذهان بجرعات منخفضة عند الضرورة



مثال سريري: مدير يرفض التفويض لاعتقاده أن الموظفين يتآمرون لإزاحته، مع سجل من الشكاوى والنزاعات المهنية المتكررة.

التعريف والسمات الجوهرية

نمط متفش من عدم الثقة والشك في نوايا الآخرين يبدأ مطلع البلوغ. الفرد يفسر تصرفات الآخرين باستمرار على أنها تهديدية أو استغلالية دون أدلة كافية، ويحتفظ بضغائن لفترات طويلة، ويشك في إخلاص الشريك.

محكات DSM-5 (4 من 7 على الأقل)

- يشك دون مبرر في كون الآخرين يستغلونه أو يؤذونه أو يخدعونه
- يشغل باله المستمر بالشكوك غير المبررة حول وفاء أصدقائه
- يتردد في البوح بمعلومات خشية استخدامها ضده
- يقرأ في الملاحظات والأحداث العادية معاني مهينة أو تهديدية
- يحمل الضغائن لفترات طويلة
- يتصور هجمات على شخصيته ويرد بسرعة وغضب
- يشك مراراً في إخلاص الشريك الجنسي

اضطراب الشخصية الفصامية — Schizoid Personality Disorder

التعريف والسمات

نمط متفشي من الانفصال عن العلاقات الاجتماعية وضيق نطاق التعبير الانفعالي في البيئات الشخصية. الفرد يبدو بارد العواطف، منعزلاً، لا يرغب في العلاقات الحميمة ولا يستمتع بالتفاعل الاجتماعي.

محكات DSM-5 (4 من 7 على الأقل)

- لا يرغب في ولا يستمتع بالعلاقات الوثيقة
- يختار دائماً الأنشطة الفردية
- لا يبدي اهتماماً بالتجارب الجنسية مع الآخرين
- يستمتع بالقليل جداً من الأنشطة إن كان يستمتع بأي منها
- يفتقر إلى أصدقاء مقربين أو ثقة
- يبدو لامباليًا بمديح الآخرين أو انتقاداتهم
- يُظهر برودة عاطفية وانفصالًا أو تسطيحًا وجدانيًا

التمييز عن الفصام وعلاجه

الفارق الجوهرى عن الفصام: لا توجد هلاوس أو أوهام، والاختبار بالواقع سليم. يختلف أيضًا عن الشخصية شبه الفصامية بغياب التفكير السحري والانتهازية الغريبة.

العلاج

- العلاج النفسي الفردي: بناء تدريجي للتواصل الانفعالي
- تدريب المهارات الاجتماعية: في إطار جماعي بحذر
- دوائيًا: لا يوجد دواء نوعي؛ تُعالج الأعراض المرافقة كالاكتئاب



مثال سريري: مبرمج موهوب يعيش وحده منذ سنوات، يرفض الدعوات الاجتماعية ولا يشعر بأي وحدة أو ضيق من ذلك.

اضطراب الشخصية شبه الفصامية — Schizotypal Personality Disorder



تفكير وكلام غريب

تفكير غريب وكلام مراوغ — استيعابي جدًا أو تجريدي جدًا أو صياغته غير مألوفة — دون الوصول إلى تفكك الفصام.



المظهر والسلوك الغريب

سلوك أو مظهر غريب أو شاذ. أفكار إشارية — تفسير أحداث عشوائية على أنها موجهة شخصيًا إليه.

العلاج

- لتعديل المعتقدات الغريبة والقلق الاجتماعي CBT
- تدريب المهارات الاجتماعية
- مضادات الذهان بجرعات منخفضة عند الأفكار شبه الوهامية



التشوهات الإدراكية والتفكير السحري

معتقدات غريبة أو تفكير سحري يؤثر على السلوك كالخرافات والتخاطر وحس السادس. خبرات إدراكية غير عادية كالأحاسيس الجسدية الخادعة.



العلاقات الاجتماعية المضطربة

قلق اجتماعي حاد لا يتراجع مع الألفة، يرتبط بالخوف الزوراني لا بالحكم السلي على الذات. افتقار إلى الأصدقاء المقربين.

التشخيص الفارق

يختلف عن الفصام بغياب الأوهام الراسخة والهلاوس المستمرة والتفكك الواضح. يختلف عن الفصامية بوجود التشوهات المعرفية والتفكير السحري والقلق الاجتماعي.

اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع — Antisocial Personality Disorder

التعريف والسمات الجوهرية

نمط متفشي من تجاهل حقوق الآخرين وانتهاكها يبدأ منذ الطفولة أو المراهقة ويستمر حتى البلوغ. يتضمن الكذب المتكرر، الاندفاعية، السلوك العدواني، وانعدام الندم.

محكات DSM-5

- يُشترط عمر 18 سنة أو أكثر
- دليل على اضطراب المسلك (Conduct Disorder) قبل عمر 15 سنة
- عدم الامتثال للقواعد والقوانين الاجتماعية
- الخداع المتكرر والكذب والتلاعب لمصلحة شخصية
- اندفاعية وعجز عن التخطيط المسبق
- تهيج وعدوانية متكررة
- إهمال كامل لسلامة الآخرين والنفس
- عدم الندم على إيذاء الآخرين أو سرقتهم

التحديات العلاجية والعلاج

يُعدّ هذا الاضطراب من أصعب الاضطرابات علاجًا نظرًا لانعدام البصيرة وضعف الدوافع الداخلية للتغيير. التحالف العلاجي صعب التكوين.

- تعزيز التفكير النتائجي وضبط الاندفاعية: CBT
- العلاج الجماعي: مع الحذر من استغلال المجموعة
- دوائيًا: لا يوجد علاج نوعي؛ مضادات الاندفاعية عند الضرورة



شرط اضطراب المسلك قبل 15 سنة ضروري للتشخيص — لا يكفي تاريخ السلوك الإجرامي وحده في البلوغ.

اضطراب الشخصية الحدية — Borderline Personality Disorder

نمط متفشي من عدم الاستقرار في العلاقات الشخصية والصورة الذاتية والعواطف، مع اندفاعية واضحة. يُعدّ من أكثر اضطرابات الشخصية تمثيلًا في العيادات النفسية.

3 اضطراب الهوية اضطراب في الهوية: صورة ذاتية أو إحساس بالذات غير مستقر بشكل ملحوظ	2 علاقات غير مستقرة نمط من العلاقات المتقلبة بين التبجيل والاستهانة (Splitting)	1 الخوف من الهجر جهود محمومة لتفادي الهجر الحقيقي أو المتخيّل
6 عدم استقرار عاطفي تفاعلية وجدانية حادة: ساعات من الانزعاج أو التهيج أو القلق (نادراً أكثر من يومين)	5 سلوك انتحاري / إيذاء ذات السلوك الانتحاري أو التلويح به أو التهديد أو إيذاء الذات المتكرر	4 الاندفاعية اندفاعية في مجالين ضارّين محتملين: الإنفاق، الجنس، تعاطي المواد، القيادة الطائشة، الشراهة
9 أفكار زورانية عابرة أفكار زورانية عابرة مرتبطة بالضغط أو أعراض تفارق شديدة	8 غضب مكثف غضب مكثف غير ملائم أو صعوبة السيطرة على الغضب	7 الفراغ المزمن الشعور المزمن بالفراغ الداخلي

العلاج الدوائي المساند

لا يوجد دواء نوعي للاضطراب ذاته. تُستخدم الأدوية لعلاج الأعراض المصاحبة: مثبتات المزاج للتقلبات الانفعالية، ومضادات الاكتئاب لاضطرابات المزاج المرافقة، ومضادات الذهان بجرعات منخفضة للأعراض شبه الذهانية.

العلاج الجدلي السلوكي DBT

هو العلاج الأول المدعوم بالأدلة لاضطراب الشخصية الحدية. DBT وتغيير السلوك عبر: التنظيم (Acceptance) يجمع بين تقنيات التقبل الانفعالي، اليقظة الذهنية، تحمل الضيق، والفعالية الشخصية.

اضطراب الشخصية الهستيرية — Histrionic Personality Disorder

التعريف والسمات

نمط متفشي من العاطفية المفرطة والسعي للفت الانتباه. يشعر الفرد بعدم الارتياح في المواقف التي لا يكون فيها محور الاهتمام، ويستخدم مظهره الجسدي وسيلةً دائمة لجذب الانتباه.

محكات DSM-5 (5 من 8 على الأقل)

- يشعر بالانزعاج حين لا يكون محور الاهتمام
- تفاعل مع الآخرين غالبًا ما يتسم بالإغراء الجنسي غير الملائم أو الاستفزازي
- يُظهر انتقالًا سريعًا وسطحيًا في التعبير العاطفي
- يستخدم المظهر الجسدي باستمرار للفت الانتباه
- أسلوب حديثه يفتقر إلى التفاصيل ومبالغ فيه انطباعيًا
- يُظهر تمثيلًا ذاتيًا وأداءً مسرحيًا ومبالغة في التعبير العاطفي
- قابل للإيحاء بسهولة — يتأثر بالآخرين أو بالظروف
- يعتبر العلاقات أكثر حميمية مما هي في الواقع

التشخيص الفارق والعلاج

الفارق عن الحدية: السلوك الهستيري أكثر ثباتًا وأقل اندفاعية وانتحارية. الفارق عن النرجسية: الهستيري يسعى للانتباه من الجميع؛ النرجسي يسعى للإعجاب بتفوقه تحديدًا.

العلاج

- العلاج النفسي الديناميكي: استكشاف الدوافع اللاشعورية لطلب الانتباه
- تعديل الأنماط السلوكية الدرامية: CBT
- العلاج القائم على المخططات: معالجة الاحتياجات العاطفية غير المُلبّاة
- دوائيًا: علاج الأعراض المصاحبة كالاكتئاب والقلق

اضطراب الشخصية النرجسية — Narcissistic Personality Disorder

نقص التعاطف

غير راغب في التعرف على مشاعر الآخرين أو التماهي مع احتياجاتهم. يستغل الآخرين لتحقيق أهدافه الخاصة. يشعر بالحسد أو يعتقد أن الآخرين يحسدونه.

الحاجة للإعجاب المفرط

مشغول بخيالات النجاح الباهر والقوة والجمال وما شابه. يعتقد أنه مميز ويجب أن يُعامل بناءً على ذلك من قبل مؤسسات راقية فحسب.

الشعور بالعظمة

نمط متفئس من العظمة في الخيال أو السلوك: مبالغة في إنجازاته ومواهبه، توقع التعرف إليه باعتباره متفوقًا بدون إنجازات تتناسب مع ذلك.

العلاج وتحدياته

العلاج صعب لأن الفرد نادرًا ما يطلب المساعدة طوعًا. يُحضر عادةً بسبب الاكتئاب أو أزمات العلاقات.

- العلاج النفسي الديناميكي: معالجة النرجسية الوهشة والخجل الكامن
- علاج المخططات: تحدي مخطط الاستحقاق
- تعزيز التعاطف وتوقعات واقعية: CBT

محكات DSM-5

يتطلب التشخيص 5 من 9 معايير موزعة على: العظمة، الخيالات، التميز، الحاجة للإعجاب المفرط، الاستحقاق، الاستغلالية، نقص التعاطف، الحسد، الغطرسة والتعجرف.

التشخيص الفارق

يختلف عن المعادية للمجتمع بأن النرجسي يبحث عن الإعجاب لا فقط الاستغلال. يختلف عن الهستيري بأن العظمة محورية وليس جذب الانتباه المجرد.

اضطراب الشخصية التجنبية — Avoidant Personality Disorder

التعريف والسمات الجوهرية

نمط متفشي من الكف الاجتماعي ومشاعر الكفاءة الضعيفة والحساسية الفائقة للتقييم السلبي. يتجنب الأنشطة المهنية التي تنطوي على تواصل شخصي كبير خشية النقد أو الرفض.

محكات DSM-5 (4 من 7 على الأقل)

- يتجنب الأنشطة المهنية التي تتطلب تواصلًا مع الآخرين خشية النقد أو الرفض
- لا يرغب في الاختلاط مع الناس إلا إن كان متيقنًا من أنه محبوب
- يُظهر انكفاءً في العلاقات الحميمة خشية الإهانة أو السخرية
- مشغول البال بإمكانية انتقاده أو رفضه في المواقف الاجتماعية
- مكبّل في المواقف الشخصية الجديدة بسبب مشاعر الكفاءة المنخفضة
- يرى نفسه غير كفء اجتماعيًا أو ضعيف الجاذبية أو أدنى من الآخرين
- يتحاشى تحقّل المخاطر الشخصية أو الانخراط في أي نشاط جديد

التشخيص الفارق والعلاج

الفارق عن الرهاب الاجتماعي: التجنبية نمط شخصية متفشي وليس خوفًا محددًا من المواقف الاجتماعية. غالبًا يتداخل التشخيصان — يمكن تواجدهما معًا.

العلاج

- إعادة البناء المعرفي لمعتقدات الكفاءة وتدريبية التعرض للمواقف: CBT الاجتماعية
- تدريب المهارات الاجتماعية: بناء الثقة التدريجي
- علاج المخططات: معالجة مخطط العيب والخجل
- دوائيًا: مثبطات استرداد السيروتونين (SSRIs) لعلاج القلق الاجتماعي المصاحب

اضطراب الشخصية الاعتمادية — Dependent Personality Disorder

التعريف والسمات

نمط متفشي من الحاجة الشديدة للرعاية تؤدي إلى سلوك تبعي وخضوعي والخوف من الانفصال. الفرد يجد صعوبة بالغة في اتخاذ قرارات يومية بدون إسداء نصيحة مفرطة من الآخرين.

محكات DSM-5 (5 من 8 على الأقل)

- يعاني من صعوبة في اتخاذ القرارات اليومية بدون نصائح ومساعدة مفرطة
- يحتاج إلى الآخرين لتحمل مسؤولية معظم مجالات حياته الرئيسية
- يجد صعوبة في التعبير عن الخلاف خشية فقدان الدعم
- صعوبة في بدء مشاريع أو القيام بأمر بمفرده (لانعدام الثقة)
- يبالغ في محاولاته للحصول على الرعاية والدعم
- يشعر بعدم الارتياح الشديد أو العجز حين يكون وحيداً
- يبحث عن علاقة جديدة كمصدر رعاية ودعم فور انتهاء علاقة وثيقة
- مشغول البال بالخوف الغير واقعي من أن يُترك ليعتني بنفسه

التشخيص الفارق والعلاج

الفارق عن الحدية: الاعتمادي يتحمل الهجر بسلبية وحزن؛ الحدي يتفاعل بغضب واندفاع شديد.

العلاج

- تعزيز الاستقلالية وبناء الكفاءة الذاتية: CBT
- العلاج الديناميكي: استكشاف مصادر الاعتمادية في العلاقات المبكرة
- علاج المخططات: معالجة مخطط التبعية وعدم الكفاءة
- دوائياً: علاج القلق أو الاكتئاب المصاحب عند الحاجة



التدرج في التحرر من الاعتمادية جوهري — التسريع يُحدث قلقاً شديداً ويؤدي إلى انقطاع العلاج.

اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية — OCPD

OCD يختلف جوهريًا عن اضطراب الوسواس القهري — *Obsessive-Compulsive Personality Disorder*

الفارق الجوهري: OCPD vs OCD

محكات DSM-5 (4 من 8 على الأقل)

المعيار	OCPD	OCD
البصيرة	يرى سلوكه مثاليًا (Ego-) (Syntonic)	يعاني ضيقًا منه (Ego-Dystonic)
الوساوس	لا توجد وساوس تقحمية	وساوس وأفعال قهرية واضحة
الانتشار	نمط شخصية متفشي	اضطراب قلق محدد الأعراض

- انشغال بالتفاصيل والقواعد والقوائم والنظام والجداول الزمنية لدرجة ضياع الهدف الرئيسي
- كمالية تعيق إنجاز المهام
- إخلاص مفرط للعمل والإنتاج على حساب الفراغ والصدقات
- إفراط في التدقيق والتشكك في أمور الأخلاق والقيم (لا لدوافع دينية)
- عجز عن التخلص من أغراض بالية لا قيمة لها
- تردد في التفويض أو العمل الجماعي ما لم يُنفَّذ بطريقة تحديداً
- بخل في الإنفاق على النفس والآخرين — المال يُدَّخر احتياطًا للكوارث
- جمود وعناد

العلاج

- تحدي الكمالية وتدريب الإرجاء: CBT
- علاج المخططات: معالجة مخطط المعايير العالية
- دوائياً: مثبطات استرداد السيروتونين عند تداخل OCD

جدول مقارنة شامل: اضطرابات الشخصية العشرة

الاضطراب	المجموع ة	أبرز السمات	نمط العلاقات	مستوى البصيرة	العلاج الأكثر فعالية
الزورانية	A	الشك المزمن وعدم الثقة	دفاعية وعدائية	ضعيف	داعم CBT
الفصامية	A	الانعزال وبرود العاطفة	شبه معدومة	متوسط	فردى تدريجى
شبه الفصامية	A	التفكير السحري والغرابة	قلق وتجنب	ضعيف	دواء + CBT
المعادية للمجتمع	B	انتهاك الحقوق وانعدام الندم	استغلالية	ضعيف جدًا	سلوكى CBT
الحدية	B	عدم الاستقرار الشديد والاندفاعية	متقلبة (تبجيل/ استهانة)	متذبذب	DBT
الهستيرية	B	الدراما وطلب الانتباه	سطحية إغرائية	ضعيف	ديناميكى + CBT
النرجسية	B	العظمة وضعف التعاطف	استغلالية مع توقع التميز	ضعيف	مخططات + ديناميكى
التجنبية	C	الخوف من الرفض وتدني الكفاءة	متجنبة / خائفة	جيد	تعرض + CBT تدريجى
الاعتمادية	C	التبعية والخوف من الانفصال	تشبثية	متوسط	مخططات + CBT
الوسواسية القهرية	C	الكمالية والجمود والتدقيق	متسلطة متحكمة	ضعيف (-ego syntonic)	مخططات + CBT

التشخيص الفارق: المقارنات الجوهرية

يُعدّ التشخيص الفارق من أكثر المهارات السريرية أهمية في مجال اضطرابات الشخصية، إذ تتشابك الصور السريرية وتتداخل المعايير.

الشخصية الحدية vs ثنائي القطب

ثنائي القطب: تقلبات مزاجية لها بداية ونهاية محددتان ومرتبطة بالنوم والطاقة. الحدية: تقلبات ساعات (لا أيام)، مرتبطة بالعلاقات الشخصية، مع إيذاء ذات واضطراب هوية. يمكن تشخيصهما معًا.

الوسواس القهري OCD vs الشخصية الوسواسية OCPD

OCD: وسواس تقحمية مستهجنة: Ego-Dystonic وأفعال قهرية لتخفيض القلق.
OCPD: نمط كمالي متفشٍ يرى فيه الفرد: Ego-Syntonic لا — نفسه صحيحًا ومثاليًا. توجد وسواس تقحمية.

الفصام vs الشخصية الفصامية vs شبه الفصامية

الفصام: هلاوس راسخة وأوهام منظمة، تدهور وظيفي حاد. الفصامية: انعزال وبرود عاطفي دون تشوهات إدراكية. شبه الفصامية: تفكير سحري وغرابة لكن دون هلاوس راسخة — الأقرب للطيف الفصامي.

الشخصية النرجسية vs المعادية للمجتمع

النرجسية: استغلال الآخرين بدافع الاستحقاق والعظمة، يسعى للإعجاب والتقدير. المعادية: استغلال بدافع الاندحاس وانعدام الضمير، لا يسعى للإعجاب ولا يبالي به.

الشخصية التجنبية vs الرهاب الاجتماعي

الرهاب الاجتماعي: خوف محدد من المواقف الاجتماعية، بصيرة جيدة، يرغب في التواصل. التجنبية: نمط شخصية متفشٍ في كل مجالات الحياة، تدني تقدير الذات والكفاءة الأساسي.

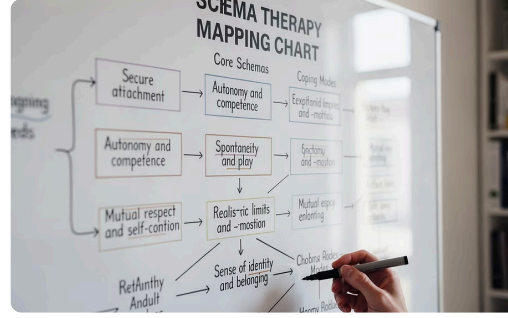
العلاج النفسي لاضطرابات الشخصية

لا يوجد دواء معتمد لعلاج اضطرابات الشخصية ذاتها — العلاج النفسي هو حجر الأساس. تُستخدم الأدوية فقط لعلاج الأعراض المصاحبة.



العلاج الدوائي المساند

يُستخدم لعلاج الأعراض المصاحبة:
SSRIs للقلق والاكتئاب، مثبتات المزاج
للتقلبات، مضادات الذهان منخفضة
الجرعة للأعراض شبه الذهانية
والاندفاعية الشديدة.



العلاج القائم على المخططات — Schema Therapy

يستهدف المخططات المبكرة غير
المتكيفة (Early Maladaptive
Schemas) الناجمة عن احتياجات
عاطفية لم تُلبّ في الطفولة. فَعَال
بشكل خاص للحدية والنرجسية
والاعتمادية.



العلاج الجدلي السلوكي — DBT

ظُور خصيصًا لاضطراب الشخصية
الحدية. يجمع التقبل والتغيير. يركز
على: التنظيم الانفعالي، اليقظة
الذهنية (Mindfulness)، تحمل الضيق،
والفعالية الشخصية. فرديًا وجماعيًا.



العلاج المعرفي السلوكي — CBT

الأكثر استخدامًا وأدلة للتجنيبة
والوسواسية. يستهدف إعادة البناء
المعرفي وتعديل الأنماط السلوكية
المختلفة. فَعَال في علاج أعراض القلق
والاكتئاب المصاحبة.

حقائق علمية وإحصاءات اضطرابات الشخصية

40-60%

التداخل مع الاكتئاب

ما بين 40 و60% من مرضى الاكتئاب المزمن لديهم تشخيص مرافق لاضطراب شخصية

10-15%

انتشار عام في المجتمع

يُقدّر DSM-5 معدل انتشار اضطرابات الشخصية في المجتمع العام بين 10 و15%

50%

العامل الوراثي

تشير دراسات التوائم إلى أن نحو 50% من تباين سمات الشخصية يُعزى لعوامل وراثية

1-2%

الشخصية الحدية

انتشار الحدية في المجتمع 1-2%، وتصل إلى 20% في العيادات النفسية الداخلية

مسار الاضطرابات عبر العمر

- تتحسن السمات مع التقدم في: (خاصة الحدية والمعادية) Cluster B العمر، خاصة بعد الأربعين
- أكثر ثباتًا وصلابة مع العمر: Cluster A و C
- التدخل المبكر في المراهقة يحسن المآل بشكل ملحوظ

عوامل الخطورة

- الصدمات المبكرة: إساءة جسدية أو جنسية أو إهمال في الطفولة
- عدم الاستقرار الأسري: الطلاق، فقدان، إدمان الوالدين
- التنمر والصدمة الاجتماعية في مرحلة المراهقة
- الاضطرابات النفسية في الوالدين كعوامل بيئية ووراثية

الخلاصة: الرسائل الجوهرية



أنماط طويلة الأمد

جميع اضطرابات الشخصية العشرة هي أنماط صلبة تبدأ مبكرًا وتمتد عبر سياقات متعددة — ليست مجرد استجابات ظرفية.



هو المرجع DSM-5

التشخيص يجب أن يستند حصريًا إلى محكات DSM-5 الموثقة، مع استبعاد الأسباب العضوية والاضطرابات الأخرى.



العلاج النفسي: حجر الأساس

لا يوجد دواء نوعي لاضطرابات الشخصية. CBT و DBT وعلاج المخططات والعلاج الديناميكي هي ركائز التدخل الفعال.



التشخيص المبكر ينقذ

التعرف المبكر على اضطرابات الشخصية — لا سيما في المراهقة — يحسن جودة الحياة ويقلل التعقيدات ويُجَنَّب مسارات مزمنة.

"اضطرابات الشخصية ليست أحكامًا على الشخص — هي أنماط مُكتسبة يمكن تفهمها وعلاجها بصبر ومهارة"



المراجع والمصادر العلمية

DSM-5-TR

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision.
American Psychiatric Association, 2022.

APA Practice Guidelines

American Psychiatric Association Practice Guidelines for the Treatment of Personality Disorders. [متاحة على موقع APA الرسمي](#).

Kaplan & Sadock

Sadock, B.J., Sadock, V.A., & Ruiz, P. *Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry* (11th ed.). Wolters Kluwer, 2015.

Textbook of Personality Disorders

Oldham, J.M., Skodol, A.E., & Bender, D.S. (Eds.). *The American Psychiatric Publishing Textbook of Personality Disorders* (2nd ed.). APA Publishing, 2014.

مراجعات علمية حديثة

مقالات مراجعة من: *Journal of Personality Disorders*, *World Psychiatry*, *Journal of Abnormal Psychology* — [متاحة عبر PubMed](#) و [Cochrane Library](#).

إعداد: وفق المعايير الأكاديمية لـ DSM-5 | للاستخدام التعليمي والتدريبي المتخصص

EVIDENCE-BASED PRACTICE

APA GUIDELINES

DSM-5-TR 2022